ஆய்வுப்படிவம்

ஆய்வின் பெயர்	நோயாளியின் அளவு 100 மி.கி	இயல்பு அளவு	குறிப்பு வரம்பு	கருத்துக்கள்
இரத்த யூரியா	30 மி.கி	20–40 மி.கி	அதிகம்	காலை 10.00 மணிக்கு தகவல் பெறப்பட்டது
கிரியாட்டினின்	1.5 மி.கி	0.8–1 மி.கி	அதிகம்	தகவல் மருத்துவர். ரகுவிடம் காலை 10.05 மணிக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. செவிலி. லூசி

9.12.2 நோயாளி வெளியேற்ற ஆவணம்

- நோயாளி வெளியேற்ற பரிந்துரைகள் மருத்துவரால் எழுதப்படும்.
- நோயாளிக்கான பரிந்துரைகளை செவிலியர் சரிப்பார்த்த பின் நோயாளியின் ஒப்புதல் கையொப்பம் பெற வேண்டும்.
- மருத்துவ மனையிலிருந்து வீடு திரும்பிய பின் உட்கொள்ள வேண்டிய அனைத்து மருந்துகளையும் பற்றி நோயாளிக்கு விளக்குதல் வேண்டும். மருந்துகளை மறு சீராய்வு செய்தல் வேண்டும்.
- ஆவணத்தின் நகல் நோயாளியிடமும் ஆவண மருத்துவ ஆவணப்பிரிவுக்கும் அனுப்பப்படவேண்டும்.

உதாரணம்: திரு. சுந்தர், எழுபது வயதானவர். அவர் மருத்துவர் திரு. நிர்மலின் பரிந்துரைப்படி இன்று (தேதி .-----) காலை 11 மணிக்கு மருத்துவ சிகிச்சைப் பிரிவிலிருந்து வெளியேறுகிறார். மூன்று வாரங்களுக்கு பின் மறு பரிசோதனைக்கு வரும்படி பரிந்துரைக்கப்பட்டு உள்ளது. வீட்டில் உண்ண வேண்டிய மருந்துகள் அறிவுரையுடன் கொடுக்கப்பட்டன. நோயாளி சுமார் 11.30 (காலை) மணிக்கு சிகிச்சைப் படிவ நகலுடன் வீடு திரும்பினார். வெளியேற்ற அறிக்கை நோயாளியிடம் கொடுக்கப்பட்டது. ஏனைய அறிக்கைகள் மருத்துவமனையின் மருத்துவப் பதிவு சேமிப்பு அறைக்கு அனுப்பப்பட்டது.

9.12.3 இரத்தம் செலுத்துதலின் ஆவணம்

இரத்தம் செலுத்துதல் பின்வருமாறு ஆவணப்படுத்தப்படுகிறது

- இரத்தத்தை உட்செலுத்தும் முன்பு கீழ்கண்ட தகவல்களை சரிப்பார்த்தல் வேண்டும்.
- இரத்தம் பெறுபவரின் பெயர், வயது, பாலினம், மருத்துவப் பிரிவு, உள்நோயாளி எண், இரத்தப்பிரிவு, இரத்த அணுக்களின் வகை, தொற்று நோயற்ற தன்மை
- இரத்தம் உட்செலுத்துதல்: (தொடங்கும் நேரம் உட்செலுத்தும் அளவு)
- உட்செலுத்துதல் மாற்றங்கள்: (உட்செலுத்தும் அளவில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள்)
- இரத்தம் உட்செலுத்துதல் நிறைவடைதல் (இரத்தம் ஏற்றுதல் நிறைவடையும் நேரப்பதிவு)

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_9.indd 298 22-02-2019 3.44.56 PM